Psychologie sociale et relation de soin

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Champ

La psychologie sociale étudie comment autrui, réel, imaginé ou implicite, influence les pensées, émotions et comportements.

Influence

Conformisme : se rapprocher de la majorité ; obéissance : répondre à une autorité ; normalisation : construire une norme commune ; persuasion : agir sur les attitudes par un message.

Trois niveaux

Stéréotype : croyance généralisée sur un groupe. Préjugé : attitude ou évaluation envers ce groupe. Discrimination : traitement défavorable ou inégal dans les actes.

Attribution

Expliquer une conduite par la personnalité peut masquer la situation. Rechercher les contraintes, les normes et les informations disponibles avant de conclure.

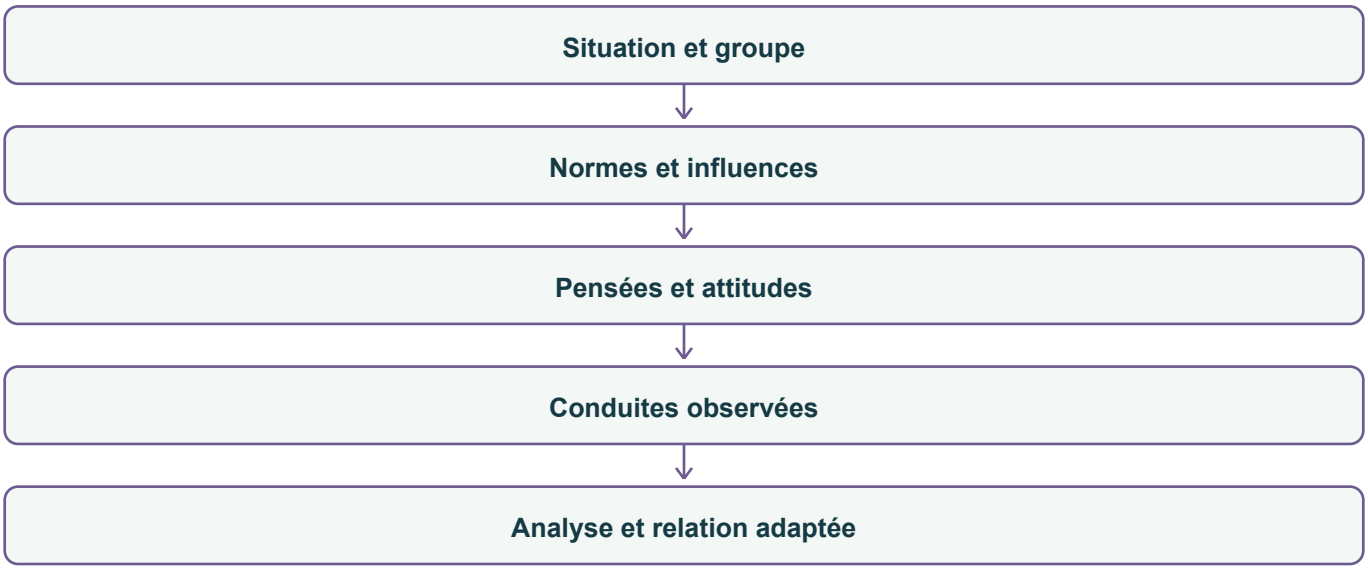
Groupes et identité

L’appartenance peut soutenir la coopération mais aussi favoriser un biais envers son propre groupe. Examiner les règles implicites de l’équipe.

Soins

Décrire les faits, vérifier les représentations et soutenir une décision comprise. Une norme d’équipe ne dispense pas d’examiner la sécurité et les droits de la personne.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Stéréotype et discrimination sont-ils identiques ? Non : croyance et conduite sont distinctes.

Conformisme = obéissance ? Non : pression du groupe et autorité diffèrent.

Peut-on expliquer tout comportement par la personnalité ? Non, il faut examiner le contexte.

Sources et portée

UE B2 DOC 5 PSYCHOLOGIE SOCIALE.pdf

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.

UE B.2

PSYCHOLOGIE SOCIALE

C'est quoi ?

La **psychologie sociale** étudie **comment les pensées, les émotions et les comportements des individus sont influencés par les autres**, qu'ils soient présents de façon réelle, imaginaire ou simplement implicite. Elle cherche à comprendre comment nous sommes affectés par les **interactions sociales** et les **normes culturelles**.

Elle se situe à l'intersection de la **psychologie cognitive** (les processus mentaux internes) et de la **sociologie** (les comportements de groupe), mais se concentre sur l'**impact du social sur l'individu**.

> *Les processus mentaux comme la perception et la mémoire sont détaillés dans la fiche **"Psychologie cognitive"** de cette même UE.*

L'influence sociale

L'influence sociale désigne la façon dont nos actions et nos opinions sont affectées par les autres. Elle prend plusieurs formes :

- **La persuasion** : convaincre quelqu'un de changer d'avis ou de comportement. Son efficacité dépend de la **source** (sa crédibilité), du **message** (un message bilatéral, qui présente le pour et le contre, est souvent plus convaincant) et du **destinataire** (son état émotionnel, sa réceptivité).
- **Le conformisme** : modifier son comportement pour correspondre à celui du groupe, par désir d'appartenance. L'**expérience d'Asch** (années 1950) a montré qu'environ 75 % des participants se conforment au moins une fois à un avis majoritaire manifestement faux.
- **L'obéissance à l'autorité** : modifier son comportement pour suivre les ordres d'une autorité perçue comme légitime. L'**expérience de Milgram** (années 1960) a montré que la majorité des participants obéissaient jusqu'à administrer des chocs potentiellement mortels.
- **La normalisation** : la tendance d'un groupe à créer des normes communes, surtout dans les situations ambiguës.

Stéréotypes, préjugés et discrimination

Ces trois notions, souvent confondues, se distinguent par leur nature :

Notion	Nature	Définition
Stéréotype	Cognitive	Croyance simplifiée et généralisée sur un groupe (ex. « les personnes âgées sont fragiles »).
Préjugé	Affective	Attitude ou sentiment négatif envers un groupe, fondé sur des stéréotypes.
Discrimination	Comportementale	Traitement injuste ou inégal d'une personne en raison de son appartenance à un groupe.

Plusieurs expériences ont éclairé ces mécanismes : **Tajfel** a montré que de simples distinctions arbitraires suffisent à créer un biais en faveur de son propre groupe ; l'**expérience des poupées de Clark** a révélé l'impact des stéréotypes raciaux sur l'estime de soi des enfants.

Les théories de la communication

La communication est centrale en psychologie sociale. Deux théories sont à connaître :

- **L'École de Palo Alto** : elle distingue la communication **verbale** (les mots) et **non verbale** (expressions, ton, gestes, posture, distance).
- **La théorie de la double contrainte** (*double bind*) : une personne reçoit des **messages contradictoires** (ex. « Sois spontané ! », une injonction impossible à satisfaire). Cette communication paradoxale génère confusion, frustration et conflits.

Les dynamiques de groupe

Les dynamiques de groupe sont les processus qui se produisent au sein d'un groupe :

- **Formation et cohésion** : les groupes se forment autour d'objectifs communs. La **cohésion** (la force des liens) favorise la communication, la coopération et la satisfaction. Une équipe soignante soudée collabore mieux.
- **Normes et rôles** : les **normes** sont des règles non écrites qui régissent les comportements ; chaque membre y tient un **rôle**, formel ou informel.

- **L'effet Hawthorne** : les individus **modifient leur comportement lorsqu'ils se savent observés**. L'attention portée aux personnes améliore leur motivation.
- **L'expérience de Lewin** : les discussions en petit groupe changent les opinions plus efficacement qu'un discours ou une conférence.

Quel est le rôle IDE ?

- **Prendre conscience de ses propres stéréotypes et préjugés** pour ne pas offrir des soins inégaux selon le profil du patient
- **Soigner sa communication non verbale** : le ton, le regard et la posture transmettent souvent plus que les mots
- **Comprendre les dynamiques d'équipe** pour mieux collaborer et désamorcer les conflits
- **Repérer les phénomènes de groupe** (conformisme, pression, obéissance) qui peuvent nuire à la qualité ou à la sécurité des soins
- **Utiliser un langage respectueux et inclusif**, sans supposition sur le patient selon son apparence ou ses origines
- **Adapter la persuasion à visée éducative** (observance, prévention) en s'appuyant sur une relation de confiance

Les 5 réflexes IDE

1. **Traquer ses propres biais** : on peut être moins attentif à un patient sans s'en rendre compte, la réflexion sur ses préjugés est un devoir professionnel
2. **Distinguer stéréotype, préjugé et discrimination** : le premier est une idée, le deuxième une émotion, le troisième un acte
3. **Accorder son verbal et son non verbal** : annoncer « tout va bien » avec un regard fuyant crée un message paradoxal qui inquiète plus qu'il ne rassure
4. **Oser questionner un ordre qui heurte l'éthique** : l'expérience de Milgram rappelle que l'obéissance aveugle est dangereuse
5. **Cultiver la cohésion d'équipe** : une équipe soudée fait moins d'erreurs et prend mieux soin des patients

Sources

- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier : UE B.2 Sciences humaines et sociales
- Solomon Asch : expériences sur le conformisme
- Stanley Milgram : expérience sur l'obéissance à l'autorité
- Henri Tajfel : théorie de la catégorisation sociale
- École de Palo Alto (Paul Watzlawick) : axiomes de la communication
- Kurt Lewin : dynamique de groupe
- Elton Mayo : études de Hawthorne

Cours rédigé par Lily Bailly · **usemypatient.com** · reproduction et partage interdits

Exemplaire personnel de Laetitia Hélary · laetitiahlary@yahoo.fr